Mésothéliome pleural malin

chez un ancien calorifugeur exposé à l'amiante — cas clinique évolutif

Présenté par **BABAAISSA Zakaria** · Encadrement : **Dr. S. Labouabi** · Module de médecine du travail · 6ème année · Faculté de médecine de Laghouat · 2026/2027

Résumé du cours

1. Définition

Tumeur **maligne primitive**, très agressive, née des **cellules mésothéliales** qui tapissent la plèvre (≈ 90 %), plus rarement le péritoine ou le péricarde.

2. Étiologie et latence

- **Amiante** : facteur majeur et avéré (> 80 % des cas) ; amphiboles plus agressives que le chrysotile.
- **Tabac** : pas un facteur inducteur du mésothéliome (≠ cancer bronchopulmonaire).
- **Latence** : 20 à 50 ans après la 1re exposition.

3. Secteurs à risque en Algérie

Fibrociment (plaques, conduites) · Bâtiment (rénovation, démolition) · Mécanique automobile (freins, embrayages) · Chantiers navals (isolation thermique, calorifugeage, chaudronnerie).

4. Physiopathologie

Inhalation de fibres → migration vers la plèvre → irritation mécanique, stress oxydatif, inflammation chronique → lésions de l'ADN → transformation maligne des cellules mésothéliales.

5. Plaques pleurales ou mésothéliome ?

- **Plaques** : fibrose localisée ± calcifiée de la plèvre pariétale, **bénigne**, asymptomatique, marqueur d'exposition.
- **Mésothéliome** : **malin**, épaississement nodulaire, irrégulier, circonférentiel (> 1 cm), plèvre « en cuirasse », poumon englobé et rétracté.

6. Imagerie

- **Radiographie** : épaississement pleural lobulé, opacité/épanchement unilatéral, rétraction de l'hémithorax.
- **TDM** : épaississement circonférentiel nodulaire > 1 cm, atteinte de la plèvre médiastinale, épanchement ; oriente sans prouver.

7. Clinique (et pourquoi)

- **Dyspnée** : épanchement et plèvre rigide compriment le poumon.
- **Douleur thoracique** : invasion de la paroi, de la plèvre pariétale, du diaphragme.
- **AEG** : syndrome inflammatoire tumoral.

Signes peu spécifiques : c'est le contexte d'exposition qui oriente.

8. Diagnostic de certitude

Cytologie souvent négative → **biopsies pleurales sous thoracoscopie → histologie + immunohistochimie**.
Formes : épithélioïde (60–80 %, meilleur pronostic), biphasique, sarcomatoïde (très agressive).

9. Prise en charge

RCP · chimiothérapie cisplatine + pémétrexed · immunothérapie (double blocage) · chirurgie/radiothérapie au cas par cas · soins de support (pleurodèse au talc, douleur).

10. Cadre médico-légal en Algérie

Tableau n° 30 (CNAS) : asbestose, lésions pleurales bénignes, **mésothéliome malin primitif (DPC 30 ans)**, autres tumeurs pleurales primitives, cancers bronchopulmonaires. Liste des travaux **indicative** (dont le calorifugeage). DPC = délai **maximal** entre fin d'exposition et 1re constatation médicale.

11. Asbestose ou mésothéliome ?

	Asbestose	Mésothéliome
Nature	Fibrose, non cancéreuse	Cancer très agressif
Siège	Parenchyme	Plèvre (membrane)
Évolution	Chronique ; ↑ risque de cancer du poumon	Pronostic très sombre

Cas clinique

B. Abdelkader, homme de **67 ans** · ancien calorifugeur, retraité

Motif de consultation : Dyspnée progressivement croissante depuis **3 mois** · Douleur thoracique **gauche** · Amaigrissement de **6 kg**

Antécédents et contexte : HTA traitée · Tabagisme : **12 paquets-années**, sevré depuis 18 ans · **Tuberculose pulmonaire traitée en 1995** (6 mois), déclarée guérie · Son **épouse** lavait ses bleus de travail à domicile pendant des années

Examen clinique : FR **23/min** · SpO_2 **93 %** (air ambiant) · Diminution du murmure vésiculaire à la **base gauche** · Matité à la **base gauche**

Le diagnostic de mésothéliome pleural malin est évoqué.

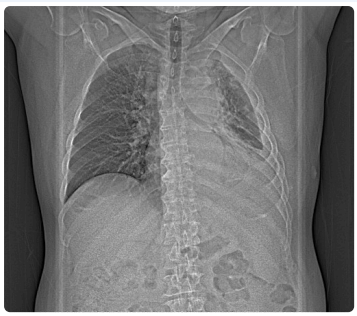
QCM 1 — Diagnostics différentiels

Quels sont les principaux diagnostics différentiels à discuter ?

A. Cancer bronchopulmonaire
B. Métastases pleurales d'un cancer extrathoracique
C. Rechute ou réactivation tuberculeuse (pleurésie tuberculeuse)
D. Pleurésie asbestosique bénigne
E. Lymphome pleural

QCM 2 — Présentation clinique

Une **radiographie thoracique** a été réalisée.



Concernant la présentation clinique, quelles propositions sont exactes ?

A. Une latence de plus de vingt ans après la dernière exposition à l'amiante rend moins probable un mésothéliome lié au travail, comparativement à une tumeur survenant dans les dix premières années.

B. La réduction de volume de l'hémithorax gauche malgré l'épanchement oriente davantage vers un mésothéliome que vers une métastase pleurale.

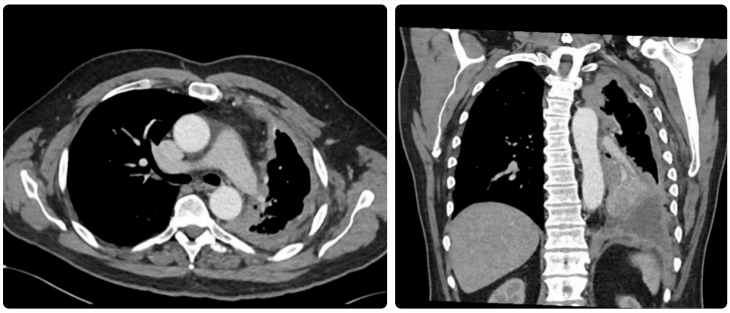
C. La découverte d'un épanchement pleural chez un ancien calorifugeur justifie une enquête d'exposition même si le patient ne rapporte spontanément aucun contact avec l'amiante.

D. Chez un patient ayant fumé et travaillé au contact d'isolants anciens, la quantification du tabagisme permet de hiérarchiser les deux expositions dans l'attribution causale du mésothéliome.

E. L'absence de plaques pleurales ou de signes radiologiques d'asbestose rend peu probable l'imputabilité d'un mésothéliome à une exposition professionnelle à l'amiante.

QCM 3 — Imagerie : scanner thoracique

Un **scanner thoracique** a été réalisé.



Concernant le scanner thoracique, quelles propositions sont exactes ?

A. Il s'agit d'une coupe axiale du thorax en fenêtre parenchymateuse, après injection.

B. Les critères de Leung (épaississement circonférentiel, nodulaire, de plus de 1 cm, atteignant la plèvre médiastinale) sont très sensibles mais peu spécifiques de malignité pleurale.

C. L'effacement des plans graisseux entre l'épaississement pleural et l'aorte thoracique ou le péricarde fait suspecter une extension locale, sans démontrer à lui seul une invasion histologique de ces structures.

D. L'adénocarcinome métastatique de la plèvre reste un diagnostic différentiel.

E. Le scanner montre un épanchement pleural droit justifiant une ponction pleurale à visée diagnostique et thérapeutique.

QCM 4 — Ponction pleurale

Ponction pleurale : liquide séro-hématique.

- Protides : **42 g/L** (protidémie 70 g/L)
- Rapport LDH pleurales / sériques : **0,8**
- Lymphocytes : **70 %**
- ADA : **22 UI/L**
- Examen direct BK et GeneXpert : **négatifs**
- Cytologie : **absence de cellules malignes**

Concernant ces résultats, quelles propositions sont exactes ?

A. Il s'agit d'un exsudat selon les critères de Light.

B. La cytologie du liquide pleural a une faible sensibilité dans le mésothéliome, rendant la biopsie indispensable.

C. Les cellules mésothéliales malignes ressemblent fortement à des cellules mésothéliales réactionnelles.

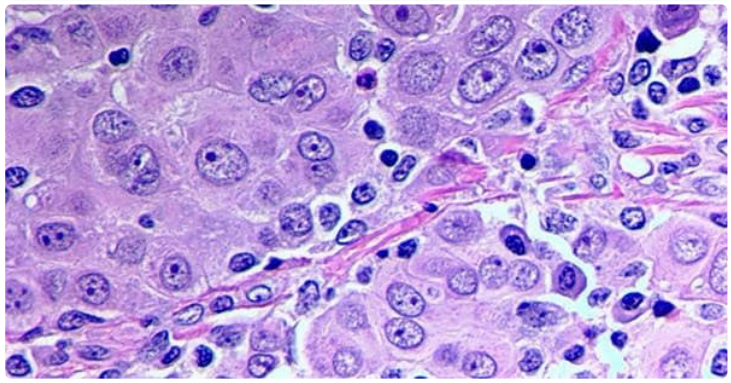
D. La présence d'un exsudat lymphocytaire chez un patient ayant des antécédents de tuberculose suggère une rechute pleurale, ce qui justifie l'instauration d'un traitement d'épreuve.

E. Devant cette première cytologie négative, une deuxième ponction pour un nouvel examen cytologique est recommandée avant d'envisager une biopsie.

QCM 5 — Biopsie et anatomopathologie

Biopsies pleurales sous thoracoscopie : prolifération tumorale d'architecture épithélioïde infiltrant le tissu adipeux pariétal. **Absence de granulome épithélioïde et gigantocellulaire, absence de nécrose caséeuse.**

Immunohistochimie : calrétinine +, WT1 +, CK5/6 +, TTF-1 −, CEA −, perte d'expression de BAP1.



Concernant la biopsie et l'examen anatomopathologique, quelles propositions sont exactes ?

A. La biopsie pour mésothéliome est réalisée à l'aveugle à l'aiguille de trocart.

B. L'immunohistochimie est l'examen indispensable et systématique pour confirmer le diagnostic de mésothéliome.

C. Le mésothéliome épithélioïde est le type le plus fréquent ; il présente le pronostic le plus favorable.

D. Une prolifération tumorale à différenciation épithélioïde à l'histologie permet de distinguer un mésothéliome épithélioïde d'un adénocarcinome pulmonaire lorsque le prélèvement est suffisamment représentatif.

E. L'absence de granulome et de nécrose caséeuse, associée à un diagnostic alternatif établi, permet d'écarter avec certitude une tuberculose pleurale.

QCM 6 — Enquête professionnelle — tableau

Enquête professionnelle et situation médico-légale

Le patient a exercé comme **calorifugeur de 1978 à 2003** dans plusieurs entreprises de maintenance industrielle. Ses tâches comprenaient la **découpe, la pose et le retrait d'anciens isolants thermiques**. Il rapporte des travaux poussiéreux, parfois en espace confiné, une ventilation insuffisante et une utilisation irrégulière des protections respiratoires.

Auparavant, en **1977**, il a travaillé **6 mois comme mécanicien automobile** (remplacement de garnitures de freins et d'embrayage).

Les archives professionnelles sont **incomplètes**. Deux anciens collègues confirment des conditions de travail similaires. Aucune mesure individuelle historique de concentration en fibres n'est disponible.



Quels raisonnements sont appropriés dans le cadre réglementaire algérien ?

A. Un mécanicien (freins) atteint de mésothéliome peut être reconnu même si son métier n'est pas cité dans le tableau.

B. Les deux expositions successives imposent de déterminer laquelle est responsable avant toute reconnaissance.

C. Le délai de prise en charge de 30 ans correspond à la durée minimale d'exposition professionnelle à l'amiante devant être démontrée pour permettre la reconnaissance.

D. Le métier de mécanicien n'étant pas répertorié dans le tableau n° 30, cette pathologie sera déclarée comme maladie à caractère professionnel.

E. L'absence de mesures individuelles historiques de concentration en fibres n'exclut pas la reconnaissance de la maladie professionnelle.

QCM 7 — Chronologie et délais

Chronologie

1977 Première exposition suspectée (mécanicien)
2003 Dernière exposition suspectée
2024 Radiographie thoracique (bilan préopératoire d'une hernie inguinale) : discret épaississement pleural gauche, non signalé
Juin 2026 Début des symptômes
18 sept. 2026 Première constatation médicale documentée
2 oct. 2026 Confirmation histologique
Situation actuelle : diagnostic confirmé, origine professionnelle suspectée, reconnaissance par la CNAS non encore prononcée.

Concernant les dates du dossier, quelles propositions sont exactes ?

A. Juin 2026 fait foi pour fixer le point de départ officiel de l'incapacité ou de la prise en charge.

B. Le délai de prise en charge se calcule à partir de 1977, date de fin de l'activité de mécanicien, première exposition documentée.

C. Une date de cessation d'exposition établie en 2003 et une première constatation médicale retenue en septembre 2026 correspondent à un intervalle d'environ 23 ans ; cet intervalle est inférieur à 30 ans, donc le délai de prise en charge n'est pas respecté.

D. La radiographie de 2024 ne peut être retenue comme première constatation médicale que si l'épaississement pleural qu'elle montre est rattaché, a posteriori, au mésothéliome.

E. Aucune durée minimale d'exposition n'est légalement exigée dans le tableau pour le mésothéliome.

QCM 8 — Certificat médical

Un **certificat de maladie professionnelle** a été établi.



Un certificat de maladie professionnelle a été établi. Cochez les réponses justes :

A. Ce certificat est établi en trois exemplaires : le premier est adressé à la CNAS, le deuxième à l'employeur et le troisième est remis à la victime.

B. La case « maladie professionnelle » ne peut être cochée que si le médecin a préalablement vérifié que les conditions du tableau (délai de prise en charge, liste des travaux) sont réunies.

C. C'est le médecin-conseil de la CNAS qui est chargé d'établir la relation entre la maladie et la profession, et non le médecin rédacteur.

D. Ce certificat doit être validé par un médecin du travail avant sa transmission à la CNAS.

E. L'exemplaire remis au patient lui permet d'effectuer lui-même la déclaration auprès de la CNAS.

QCM 9 — Preuve de l'exposition et ayants droit

L'exposition professionnelle paraît plausible, mais certaines **archives sont manquantes**.

Quelles propositions sont exactes ?

A. Si le patient a déjà passé des scanners thoraciques montrant des plaques pleurales calcifiées, ces dernières constituent une « signature » radiologique incontestable d'une exposition passée à l'amiante.

B. Si l'épouse développait un mésothéliome, elle ne pourrait pas être reconnue en maladie professionnelle au titre du tableau n° 30.

C. Il n'est pas obligatoire de prouver scientifiquement la présence de fibres. Il faut prouver l'exercice de la profession et la nature des tâches.

D. L'existence d'une exposition extraprofessionnelle exclut une origine professionnelle.

E. En cas de décès du patient des suites de sa maladie professionnelle, ses ayants droit, dont son épouse, sont indemnisés par la CNAS.

QCM 10 — Prévention

L'enquête révèle que **d'autres travailleurs** ont effectué des travaux comparables sur les mêmes installations.

Quelles propositions sont exactes ?

A. Le port d'un appareil de protection respiratoire adapté et la surveillance médicale périodique constituent les principales mesures de prévention primaire, puisqu'ils permettent d'éviter l'apparition de la maladie.

B. La traçabilité de l'exposition professionnelle et la surveillance médicale des travailleurs exposés s'inscrivent dans une démarche de prévention secondaire.

C. Le reclassement professionnel d'un travailleur atteint d'un mésothéliome pleural malin constitue une mesure de prévention secondaire visant à dépister précocement les complications.

D. Le médecin du travail ne communique jamais le diagnostic à l'employeur.

E. Tout médecin qui constate une maladie à caractère professionnel doit la signaler, même hors tableau.

Les réponses :

1. A+B+C+E **2.** B+C **3.** C+D **4.** A+B+C **5.** B+C **6.** A+E
7. D+E **8.** E **9.** A+B+C+E **10.** B+D+E

Images de scanner : Radiopaedia.org · Illustrations de la plèvre : M. Skalski (CC BY-NC-ND)